

中国医学科学院阜外医院诊断报告

【患者信息】

姓名	李鸿涛	性别	男
年龄	58岁	住院号	202509034
入院日期	2024年12月19日 10:00	出院日期	2024年12月26日 11:00
科室	内分泌科二病区	床位号	15床

【主诉】

多饮、多尿、体重下降3个月，伴头晕、视物模糊1周。患者近3个月来无明显诱因出现口渴多饮（每日饮水约3000-4000 ml）、多尿（夜尿2-3次/晚）、体重减轻约6kg，伴乏力、倦怠。近1周出现间断性头晕、眼花，晨起时明显，无意识障碍，无视物旋转，无恶心呕吐。门诊查空腹血糖10.2mmol/L，糖化血红蛋白8.7%，为求进一步诊疗收入院。

【体格检查】

T 36.3°C, P 88次/分, R 18次/分, BP 158/96mmHg (右上肢), BMI 28.4 kg/m² (身高172cm, 体重84kg)。神志清楚，双瞳孔等圆对光反射灵敏。颈部未闻及血管杂音。双肺呼吸音清，未及啰音。心率88次/分，律齐。腹围106cm，腹部未见紫纹。双下肢轻度凹陷性水肿，双足背动脉搏动减弱，10g尼龙丝试验阳性提示保护性感觉减退。

【辅助检查】

口服葡萄糖耐量试验 (OGTT) (2024-12-19)：空腹血糖9.8 mmol/L，服糖后2h血糖15.2 mmol/L。
糖化血红蛋白 (HbA1c) (2024-12-19)：8.7% (参考范围4.0-6.0%)。
胰岛功能：空腹C肽1.6 ng/mL (0.8-4.2)，服糖后2h C肽 3.8 ng/mL，提示胰岛β细胞功能中度受损。
糖尿病自身抗体：谷氨酸脱羧酶抗体 (GADA) 阴性，胰岛细胞抗体 (ICA) 阴性，支持2型糖尿病诊断。
血脂全套：TC 6.85 mmol/L↑, TG 3.42 mmol/L↑, HDL-C 0.98 mmol/L↓, LDL-C 4.56 mmol/L↑。
肾功能：血肌酐96 μmol/L, eGFR 78 mL/min/1.73m², 尿微量白蛋白/肌酐比值 (UACR) 85 mg/g (正常<30)，提示糖尿病肾病G1A2期。
眼底检查：双眼底散瞳后检查示微动脉瘤，出血斑，提示非增殖期糖尿病性视网膜病变（中度NPDR）。

【诊断】

主要诊断：

- 2型糖尿病 (E11.900)
 - 糖尿病肾病 (G1A2期)
 - 糖尿病性视网膜病变 (中度非增殖期，双)
 - 糖尿病周围神经病变

次要诊断：

- 高血压病2级（极高危组） (I10)
- 高脂血症 (E78.5)
- 肥胖症 (I度) (E66.9)

【治疗方案】

一、生活方式干预：

- 糖尿病饮食管理：每日总热量控制在1600-1800 kcal，碳水化合物占总热量45%-55%，低GI食物为主。蛋白质0.8g/kg/天，脂肪<30%总热量，饱和脂肪酸<7%。

2.

运动治疗：餐后1小时开始进行中等强度有氧运动（快走、骑自行车），每次30-40分钟，每周至少5次。避免空腹运动以防低血糖。

二、药物治疗：

1. 盐酸二甲双胍片（格华止）0.5g/次，口服，每日2次（早晚餐时）。
2. 达格列净片（安达唐）10mg/次，口服，每日1次（晨起空腹）。
3. 利拉鲁肽注射液（诺和力）起始0.6mg/次，皮下注射，每日1次，1周后加量至1.2mg/次。
4. 阿托伐他汀钙片（立普妥）20mg/次，口服，每日1次（睡前）。
5. 厄贝沙坦片（安博维）150mg/次，口服，每日1次（降压、减少蛋白尿）。

【出院医嘱】

1.

严格遵医嘱服药及注射，不可擅自停药或调整剂量。使用降糖药物期间注意低血糖（心慌、出汗、饥饿、手抖），随身携带糖果或含糖饮料以防应急。

2.

每日自我监测血糖（空腹及三餐后2小时血糖），记录血糖值，门诊复诊时携带血糖记录本。血糖控制目标：空腹4.4-7.0 mmol/L，餐后2h 4.4-10.0 mmol/L，HbA1c<7.0%。

3. 每月监测血压至少2次（晨起排空膀胱后静坐5分钟测量），治疗目标<130/80 mmHg。

4.

每3个月复查糖化血红蛋白、肝功能、肾功能、血电解质、尿微量白蛋白/肌酐比值（UACR）。每6-12个月行眼底检查。

5.

足部护理：每日检查双足有无破溃、水疱、红肿、胼胝，穿柔软棉袜及合脚鞋袜。如出现足部感觉异常、疼痛、创面不愈合，立即就诊。

6. 戒烟限酒，规律作息，避免熬夜。保持乐观心态，控制情绪波动。

7. 出院后2周内内分泌科门诊复查，调整治疗方案。

主治医师：赵雪莲（主任医师）

科室：内分泌科二病区

日期：2024年12月26日